l'Assurance Maladie
Agir ensemble, protéger chacun
Caisse nationale

I. Description

Parmi les personnes de 50 à 74 ans inclus (< 75 ans), l'indicateur est validé pour celles ayant bénéficié d'un dépistage du cancer colorectal par test immunologique depuis 2 ans ou moins.

Les personnes qui n'ont plus de rectum ni de côlon, qui ont ou ont eu un cancer colorectal, qui ont un facteur de risque connu de cancer colorectal, ou qui ont récemment bénéficié d'un acte à visée diagnostique ou thérapeutique sur le côlon-rectum, sont exclues de l'indicateur.

II. Critères de ciblage

1. Population cible

« *Parmi les personnes de 50 à 74 ans inclus (< 75 ans) […]* » :
- Age ≥ 50 ans ET < 75 ans

2. Critères d'exclusion

« *Les personnes qui n'ont plus de rectum ni de côlon, […]* » :
- Antécédent de coloproctectomie totale (codes CCAM = « **HHFA028** », « **HHFA029** », « **HHFA030** », ou « **HHFA031** »)

« *[…] qui ont ou ont eu un cancer colorectal, […]* » :
- ALD active ou antécédent de cancer du côlon (code CIM10 = « **C18*** sauf **C189+0** »)
- ALD active ou antécédent de cancer de la jonction recto-sigmoïdienne (code CIM10 = « **C19*** »)
- ALD active ou antécédent de cancer du rectum (code CIM10 = « **C20*** »)

« *[…] qui ont un facteur de risque connu de cancer colorectal, […]* » :
- ALD active ou antécédent de maladie de Crohn (code CIM10 = « **K50*** »)
- ALD active ou antécédent de rectocolite hémorragique (code CIM10 = « **K51*** »)
- Antécédent de syndrome de Lynch (code CIM10 = « **C189+0** »)

« *[…] ou qui ont récemment bénéficié d'un acte à visée diagnostique ou thérapeutique sur le côlon-rectum, […]* » :
- Exérèse d'un polype de plus de 1cm de diamètre ou exérèse de 4 polypes ou plus (code CCAM = « **HHFE004** ») dans les 8 dernières années
- Destruction ou exérèse ou hémostase de lésion(s) ou de polype(s), mucosectomie rectocolique (codes CCAM = « **HHNE001** », « **HHNE002** », « **HHSE002** », « **HHSE003** », « **HHFE002** », ou « **HHFE006** ») dans les 5 dernières années
- Coloscopie totale, exploration endoscopique complète du côlon (codes CCAM = « **HHQE002** », « **HHQE003** », ou « **HHQE005** ») dans les 5 dernières années
- Scannographie du colon (code CCAM = « **HHQK484** » ou « **HHQH365** ») dans les 2 dernières années

3. Critères de réalisation de l'acte de prévention

« *[…] un dépistage du cancer colorectal par test immunologique depuis 2 ans ou moins.* » :
- Dépistage du cancer colorectal (code de facturation = « **DCC** ») dans les 24 derniers mois

III. Modalités de rémunération (FMT – Majoration Prévention)

Pour chaque patient « médecin traitant » de 50 à 74 ans au 31/12 de l'année N (à l'exclusion des patients ayant un motif d'exclusion), le médecin est rémunéré si le patient a bénéficié d'un dépistage du cancer colorectal par un test immunologique de recherche de sang dans les selles entre le 01/01 de l'année N-1 et le 31/12 de l'année N.

IV. Explications complémentaires

1. Argumentaire

L'objectif de cet indicateur est de permettre au médecin traitant de suivre l'adhésion au programme de dépistage organisé du cancer colorectal parmi ses patients éligibles à ce dépistage organisé, c'est-à-dire parmi ses patients à risque moyen de développer un cancer colorectal.

Conformément aux recommandations en vigueur, le dépistage organisé du cancer colorectal repose sur la réalisation d'un test immunologique de recherche de sang dans les selles tous les 2 ans. Autrement dit, une personne éligible est considérée comme « à jour » dès lors qu'elle a bénéficié d'un test immunologique de recherche de sang dans les selles depuis 2 ans ou moins.

Le ciblage de la population éligible, c'est-à-dire des personnes à risque moyen de développer un cancer colorectal, s'appuie sur les recommandations de la HAS et sur le référentiel de l'INCa. Il s'agit de toutes les personnes de 50 à 74 ans, à l'exclusion de celles qui se trouvent dans les situations suivantes :

- Les personnes qui n'ont plus de rectum ni de côlon, et qui ne peuvent donc plus développer de cancer colorectal ;
- Les personnes qui ont ou ont eu un cancer colorectal, qui relèvent d'une stratégie de suivi individuel adaptée ;
- Les personnes qui présentent un facteur de risque particulier (maladie inflammatoire chronique de l'intestin : maladie de Crohn ou rectocolite hémorragique), qui relèvent d'une stratégie de dépistage individuel adaptée ;
- Les personnes qui ont récemment bénéficié d'un acte à visée diagnostique ou thérapeutique sur le côlon-rectum, qui sont exclues temporairement du dépistage organisé ;
- Les personnes qui ont signalé à l'assurance maladie un motif d'exclusion du dépistage organisé du cancer colorectal (motif parmi ceux précités, ou prédisposition familiale particulière).

2. Documents de référence

L'indicateur s'appuie sur les documents suivants :

- Légifrance : https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000049025564
- INCa : https://www.e-cancer.fr/content/download/466460/7065263/file/DOCCR-Expression%20de%20besoins%20fichiers%20AM-CRCDC-INCa.pdf
- HAS : https://www.has-sante.fr/jcms/c_2772744/fr/cancer-colorectal-modalites-de-depistage-et-de-prevention-chez-les-sujets-a-risque-eleve-et-tres-eleve

3. Limites

Ces indicateurs de prévention sont calculés à partir des données de remboursement de l'assurance maladie, qui ont l'avantage de couvrir l'ensemble de la population assurée, tous régimes confondus.

Cependant, par construction, elles ne retracent que les soins qui ont fait l'objet d'une facturation à l'assurance maladie.

Tout acte ou prestation réalisé hors de ce circuit ne sera pas pris en compte dans le calcul, et en particulier :

- Les soins réalisés à l'étranger ;
- Les soins prodigués au sein de certaines structures qui ne facturent pas à l'assurance maladie (médecine du travail, PMI, médecine scolaire ou universitaire, etc.) ;
- Certains soins sans codage spécifique prodigués lors d'un séjour en établissement (actes cliniques, certains actes techniques ou de biologie financés dans le cadre du séjour, médicaments délivrés par la pharmacie interne de l'établissement, etc.).

De même, les informations contenues dans le dossier médical du patient, y compris les résultats d'examen, et y compris les documents stockés dans son dossier médical partagé ou dans « Mon Espace Santé », ne seront pas prises en compte dans le calcul.

Par ailleurs, certains professionnels ou certaines structures de soins peuvent facturer les soins réalisés de façon différée (à une date ultérieure) : cela ne fausse pas la date de réalisation du soin, mais il faudra alors attendre que l'acte ait été effectivement remboursé pour qu'il puisse être pris en compte dans le calcul.

Enfin, indépendamment du délai de facturation de l'acte par le professionnel, il existe aussi un certain délai pour que l'information soit traitée et mise à disposition, et qu'elle puisse ainsi être prise en compte dans le calcul.

En pratique, pour toutes ces raisons, il peut y avoir un écart entre les données restituées et la situation réelle du patient à un instant donné. Pour cet indicateur, les principales situations susceptibles d'entrainer de tels écarts sont les suivantes :

a. Population cible

- Risque d'écart négligeable ;

b. Critères d'exclusion

- Cancer colorectal diagnostiqué mais sans que l'ALD correspondante n'ait été demandée/renseignée, et sans que ce diagnostic n'ait été codé lors d'un quelconque séjour en établissement ;
- Maladie inflammatoire chronique de l'intestin diagnostiquée mais sans que l'ALD correspondante n'ait été demandée/renseignée, et sans que ce diagnostic n'ait été codé lors d'un quelconque séjour en établissement ;
- Acte à visée diagnostique ou thérapeutique sur le côlon-rectum réalisé dans le cadre d'un séjour en établissement, sans codage spécifique de l'acte ;

c. Critères de réalisation de l'acte de prévention

- Test immunologique de recherche de sang dans un échantillon de selles réalisé dans le cadre d'un séjour en établissement, sans codage spécifique de l'acte.

V. Précisions techniques

Source : SNIIRAM

Champ de la requête : tous régimes – patients ayant un médecin traitant

Profondeur de la requête par rapport à la date de référence de la photo :

- Pour définir la population cible : aucune profondeur (âge uniquement)
- Pour les critères d'exclusion à prendre en compte : profondeur maximale disponible
- Pour les actes traceurs à prendre en compte pour valider l'indicateur : 24 mois
- Pour les actes traceurs à prendre en compte pour l'affichage : 1er jour du mois du 48ème anniversaire

Composants utilisés pour la requête :

- ✓ DCIR → tables de consommation de soins de ville qui permet de repérer les actes et prestations générales (codes NGAP ou autres codes de facturation), les actes techniques (codes CCAM), les actes de biologie (codes NABM), ou la délivrances de médicament (codes CIP ou classes ATC) ; les soins facturés au cours d'un mois donné sont disponibles au début du mois suivant pour les assurés du régime général, et à la fin du mois suivant pour les assurés affiliés aux autres régimes (notamment MSA).
- ✓ IR_IMB_R → table du référentiel médicalisé qui permet d'identifier, en cas d'exonération du ticket modérateur (dont ALD), la pathologie précise (CIM10) associée.
- ✓ PMSI → tables relatives aux soins et pathologies précises (CIM10) associées aux séjours réalisés dans les établissements de santé publics et privés ; les soins et séjours au cours d'une année sont disponibles à la fin du 1er semestre de l'année suivante.
- × SSU → données relatives aux formulaires d'exclusion des programmes nationaux de dépistages organisés des cancer ; ces formulaires sont fournis aux assurés pour qu'ils puissent signaler à l'assurance maladie un ou plusieurs motif(s) d'exclusion dont elle n'aurait pas connaissance.

VI. Acronymes

ALD : affections de longue durée

ATC : *anatomical therapeutic chemical* → système international de classification des médicaments, permettant de regrouper plusieurs médicaments par classe thérapeutique

CCAM : classification commune des actes médicaux

CIM10 : classification internationale des maladies, version 10

CIP : code identifiant de présentation → code permettant d'identifier un médicament précis

DCIR : datamart de consommation inter-régime

IR_IMB_R : table du référentiel médicalisé

MSA : mutuelle sociale agricole

NABM : nomenclature des actes de biologie médicale

NGAP : nomenclature générale des actes professionnels

PMSI : programme de médicalisation des systèmes d'information

PMI : protection maternelle et infantile → service départemental chargé d'assurer la protection sanitaire de la mère et de l'enfant

SNIIRAM : système national d'information inter-régime de l'assurance maladie